

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КУЗБАССКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» (ГАУЗ ККСП)
Г. КЕМЕРОВО

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО И ВЗРОСЛОГО ВОЗРАСТА В РАЗРЕЗЕ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРТОДОНТИИ

Докладчик: Булгакова Елена Александровна — врач-ортодонт,
заведующая ортодонтическим отделением ГАУЗ ККСП



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

- С 1 января 2025 года клинические рекомендации Минздрава РФ перешли в статус обязательных для исполнения всеми медицинскими организациями России.
- Правовая основа: Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Научно-практическим советом Минздрава РФ и СтАР утверждено 12 обновленных клинических рекомендаций по профилю «Ортодонтия».

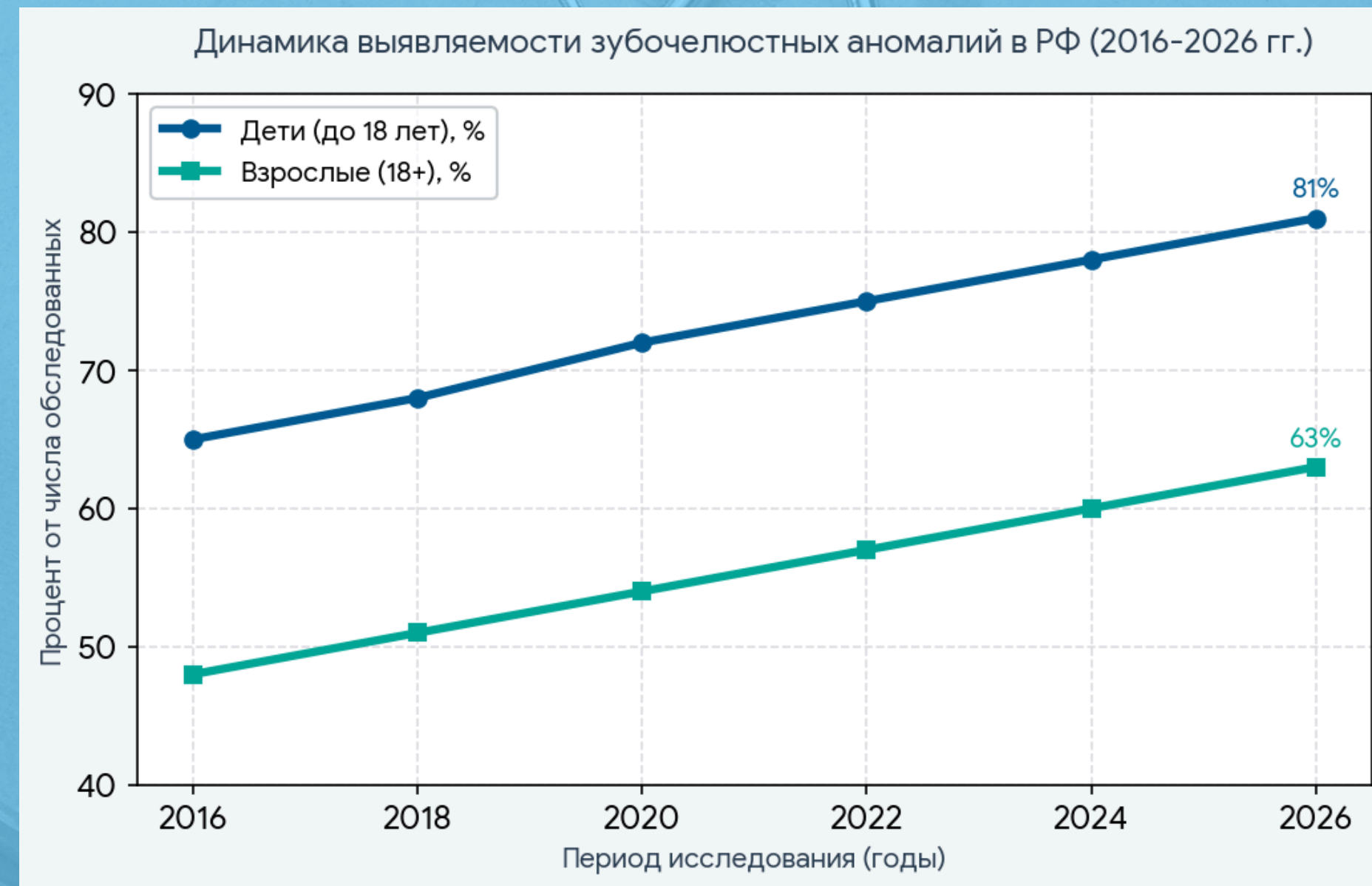
Цель внедрения: обеспечение максимальной безопасности, предсказуемости и наивысшего качества лечения пациентов.



АКТУАЛЬНОСТЬ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

На протяжении последнего десятилетия фиксируется стабильное увеличение распространенности зубочелюстных аномалий (ЗЧА). Показатели выявляемости: Патологии окклюзии диагностируются в среднем у 75–80% детей и более чем у 60% взрослого населения.

Факторы риска: Рост обусловлен характером современного питания (дефицит жесткой пищи), увеличением соматических патологий и качественным улучшением методов ранней диагностики.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. ДЕМОНСТРАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

- **Клинический диагноз:** Аномалия положения отдельных зубов. Выраженная скученность зубов в переднем отделе, сужение верхнего и нижнего зубных рядов (Код по МКБ-10: K07.3).
- **Лечебный протокол:** В соответствии с КР Минздрава РФ проведено последовательное нивелирование и расширение зубных дуг с применением современной несъемной ортодонтической техники (брекет-системы) без удаления отдельных зубов.



BEFORE

Диагноз по МКБ-10: K07.3
«Аномалии положения зубов»
(Выраженная скученность зубов
в переднем отделе, сужение
верхнего и нижнего зубных
рядов).
Диагностика по КР: Проведен
антропометрический расчет
дефицита места в зубном ряду и
3D-моделирование.

Последовательное
нивелирование и расширение
зубных дуг пассивной несъемной
самолигирующей техникой без
удаления зубов. Достигнуты
идеальные межзубные контакты,
физиологическая форма дуг и
высокая эстетика улыбки в
строгом соответствии с
критериями успешности
Минздрава РФ.

AFTER



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СОГЛАСНО КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ



ФОТОПРОТОКОЛ (ВНУТРИ- И ВНЕРОТОВОЙ)



Выполнение стандартизированных снимков лица и полости рта на этапах диагностики, промежуточного контроля и фиксации ретенции.

КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КЛКТ)

Трехмерная оценка состояния костной ткани, топографии корней зубов, симметрии челюстей и архитектоники височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).



ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЯ (ТРГ) С ЦЕФАЛОМЕТРИЕЙ



Расчет ТРГ в боковой проекции для точного определения типа роста (горизонтальный, вертикальный, нейтральный) и дифференциации зубоальвеолярных и скелетных форм аномалий.

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ (КДМ)



Изучение контрольно-диагностических моделей (цифровых или гипсовых) с расчетом дефицита места в зубном ряду и угловых параметров по классическим методикам

АНОМАЛИИ РАЗМЕРОВ ЧЕЛЮСТЕЙ (КОД МКБ-10: K07.0)

Детский возраст

- **Аппаратурный протокол:**
Использование съемной и несъемной функциональной аппаратуры для стимуляции роста при микрогнатии или сдерживания при макрогнатии.
- **Критерий Минздрава:**
Максимальное использование потенциала пубертатного ростового скачка для предотвращения развития тяжелых скелетных деформаций.

Взрослый возраст

- **Клиническая тактика:**
Ограничение возможностей изолированного перемещения зубов при выраженном несоответствии размеров челюстей.
- **Варианты лечения по стандарту:**
 1. Компенсаторное ортодонтическое лечение (зубоальвеолярный камуфляж аномалии).
 2. Комбинированный метод:
предхирургическая ортодонтическая подготовка с последующей ортогнатической операцией в условиях стационара ЧЛХ.

АНОМАЛИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ (МКБ-10: K07.1)

Клинические формы и диагностика



- КОРРЕКЦИЯ САГИТАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ (ДИСТАЛЬНОЕ/МЕЗИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) И ТРАНСВЕРЗАЛЬНЫХ АСИММЕТРИЙ ЛИЦА.
- ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 3D-ОЦЕНКА СИММЕТРИИ ПО ДАННЫМ КЛКТ И БОКОВОЙ/ПРЯМОЙ ТРГ.
- КОНТРОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУСТАВНЫХ ГОЛОВЕК ВНЧС ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ.

Ортодонтическая тактика ведения

- РАННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ (ТВИН-БЛОК, РЕГУЛЯТОРЫ ФРЕНКЕЛЯ).
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖЧЕЛЮСТНОЙ ЭЛАСТИЧЕСКОЙ ТЯГИ НА НЕСЪЕМНОЙ ТЕХНИКЕ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.
- НОРМАЛИЗАЦИЯ ТОНУСА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ И МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ КАК ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ.





**ДИСТАЛЬНАЯ
ОККЛЮЗИЯ
(МКБ-10: K07.2).
ПРОТОКОЛЫ
ЛЕЧЕНИЯ II КЛАССА
ПО ЭНГЛУ**

- **Ключевая цель:** Устранение сагиттальной щели и достижение нейтрального смыкания моляров и клыков (I класс по Энглу).
- **Стабилизация окклюзии:** Создание множественных фиссурно-бугорковых контактов в боковых сегментах для защиты ВНЧС.
- **Детский прием:** Модификация роста челюстей с помощью съемных функционально-направляющих аппаратов.
- **Взрослый прием:** Применение несъемной техники (брекеты/элайнеры) в сочетании с межчелюстными эластиками, системами дистализации и скелетной опорой (минивинтами).

МЕЗИАЛЬНАЯ ОККЛЮЗИЯ (МКБ-10: K07.2)

- **Специфика нозологии:** Прогностически сложная группа аномалий с высоким риском рецидива из-за непредсказуемого роста нижней челюсти.
 - **Обязательный контроль:** Дифференциальная диагностика истинно скелетной и зубоальвеолярной формы (на основе анализа ТРГ).
 - **Детский прием:** Раннее расширение верхней челюсти и применение лицевой маски для стимуляции ее роста.
 - **Взрослый прием:** Зубоальвеолярный камуфляж с использованием минивинтов в ретромолярной области либо комбинированное хирургическое лечение (ортогнатическая операция).
-

ГЛУБОКАЯ ОККЛЮЗИЯ (МКБ-10: K07.2)

- **Ключевая цель:** Нормализация глубины резцового перекрытия и устранение травмирующего накусывания слизистой оболочки.
 - **Механика коррекции:** Выравнивание окклюзионной плоскости (кривой Шпее), интрузия (погружение) передней группы зубов и экструзия (выдвижение) боковых.
 - **Аппаратурный выбор:** Использование ютилити-дуг, реверсионных дуг, а также накусочных элементов (плашек) и окклюзионных накладок для эффективного разобщения прикуса.
-



Вертикальная резцовая дизокклюзия (МКБ-10: K07.2)

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Устранение миофункциональных нарушений (прокладывание языка, инфантильное глотание, ротовое дыхание).

АППАРАТУРНЫЙ ВЫБОР У ДЕТЕЙ

Применение миогимнастики, съемных аппаратов с заслоном для языка и вестибулярных пластинок.

ТАКТИКА У ВЗРОСЛЫХ

Абсолютная интрузия (погружение) моляров с помощью скелетной опоры (минивинтов) для ротации нижней челюсти вверх и вперед.

ТРАНСВЕРЗАЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ ОККЛЮЗИИ

(МКБ-10: K07.2)

- Ключевая цель: Устранение несоответствия ширины зубных рядов, нормализация перекрытия в боковых отделах и центрация нижней челюсти.
- Диагностический акцент: Дифференциация зубоальвеолярных форм сужения и истинного скелетного сужения челюсти по данным КЛКТ.

- **Детский прием:** Быстрое нёбное расширение (RPE) на несъемных аппаратах (например, Марко Роса или Хаас) за счет раскрытия срединного нёбного шва.
- **Взрослый прием:** Применение скелетного расширения на минивинтах (MSE / MARPE) или хирургически ассистированное расширение (SARPE).

АНОМАЛИИ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ ЗУБНЫХ ДУГ (МКБ-10: K07.2)

Характер патологии



Коррекция резко суженных, V-образных, трапецевидных и асимметричных зубных рядов.

Клинический стандарт



Формирование анатомически правильной полуэллиптической формы для верхней челюсти и параболической — для нижней.

Механика лечения

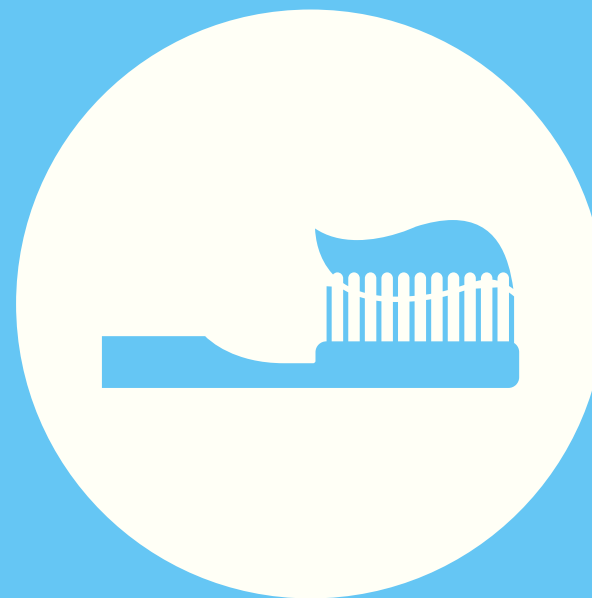


Построение дуги на основе последовательной смены ортодонтических дуг с памятью формы (от начальных круглых нитиноловых NiTi до жестких стальных прямоугольных).

АНОМАЛИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗУБОВ (МКБ-10: K07.3)



Комплексный подход: Реализация междисциплинарного протокола совместно с хирургами-стоматологами для раскрытия и вытяжения ретенированных зубов.

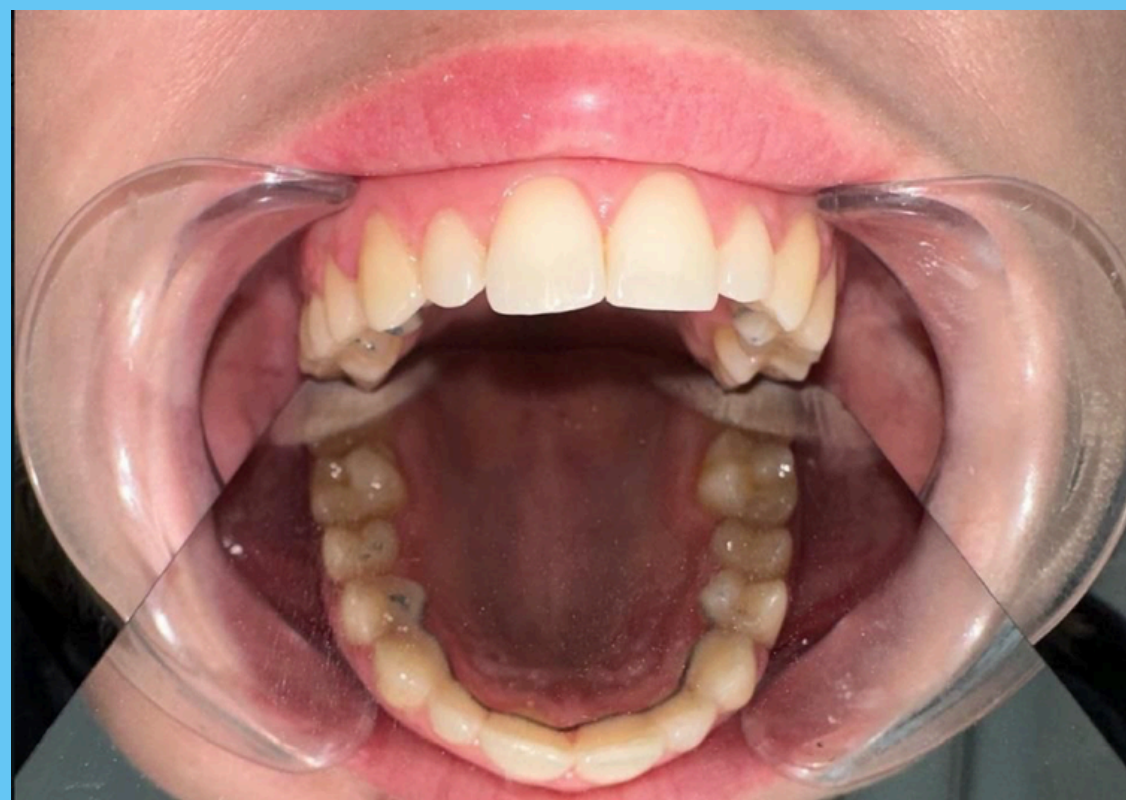


Создание пространства: Предварительное раскрытие места в зубном ряду с помощью пружин на жесткой направляющей стальной дуге.



Механика вытяжения: Дозированное биомеханическое перемещение зуба (в частности, ретенированных клыков или резцов) с использованием эластических элементов и кнопок без потери анкера (опоры).

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ И ИМПЛАНТАЦИЕЙ



- Устранение вторичных деформаций и предотвращение наклона соседних зубов в область дефекта.
- Точное раскрытие и удержание пространства для установки имплантатов в правильном положении.
- Полная синхронизация работы ортодонта с хирургами-имплантологами и ортопедами клиники.
- Создание симметричного места под будущие конструкции на примере фотографий из практики нашего отделения.

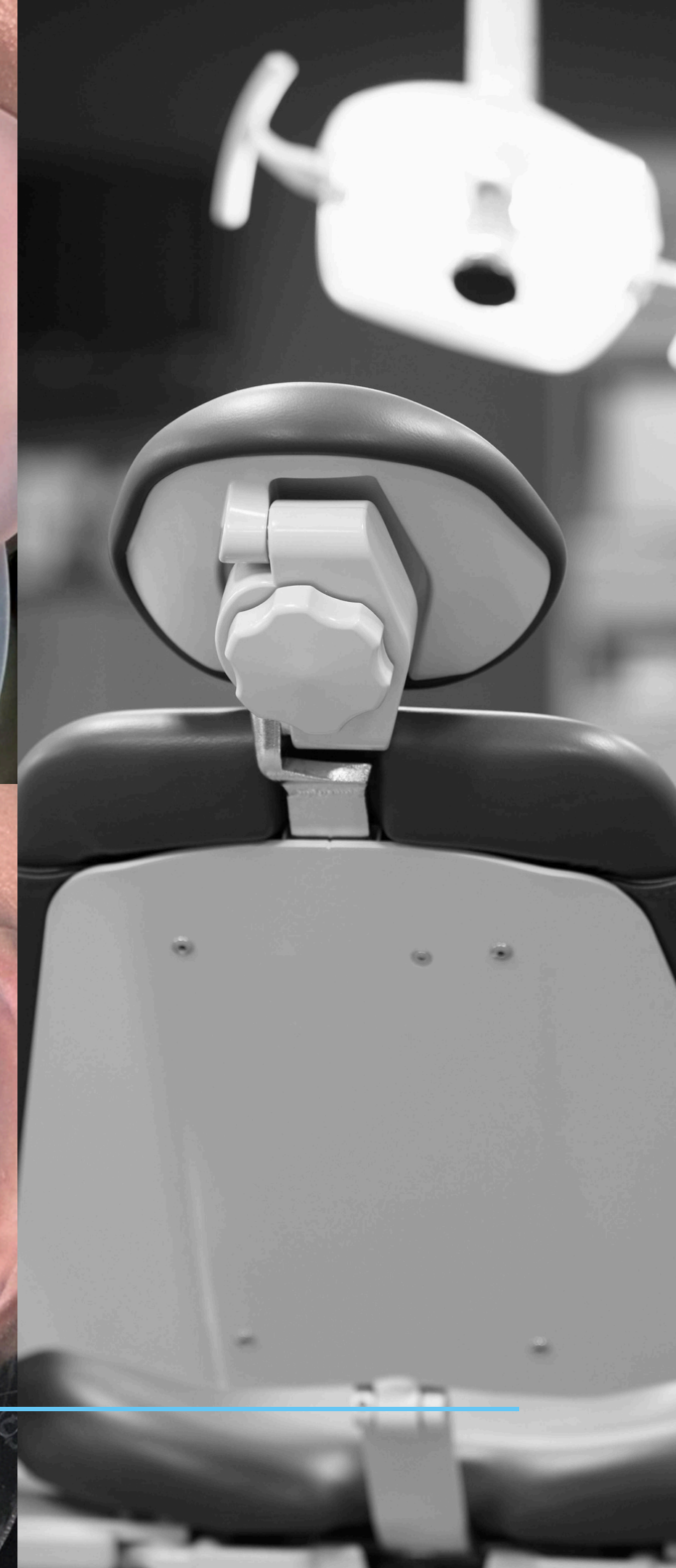
СТАНДАРТЫ ВЕДЕНИЯ РЕТЕНЦИОННОГО ПЕРИОДА. ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



- Обязательная фиксация несъемного проволочного ретейнера строго в день снятия брекет-системы.
- Прямая фиксация многожильного ретейнера на композит от клыка до клыка на обеих челюстях.
- Комбинированный протокол с использованием индивидуальных ночных капп в первый год после лечения.
- Регулярные диспансерные осмотры пациента один раз в полгода для контроля стабильности окклюзии.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

1. Исходная клиническая картина с выраженным сужением челюстей и тяжелой скученностью в переднем отделе.
2. Аппаратурное расширение зубных дуг и нивелирование окклюзионной плоскости без удаления зубов.
3. Достижение множественных плотных фиссурно-бугорковых контактов в боковых сегментах.
4. Формирование высокой эстетики улыбки и гармоничного профиля лица в соответствии с рекомендациями Минздрава.



ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Переход на цифровые стандарты диагностики с использованием внутриротового 3D-сканирования.

Виртуальное планирование перемещения зубов и детальный сетап будущего результата лечения. Цифры являются инструментами коммуникации, которыми вы можете воспользоваться для демонстрации

Обеспечение юридической безопасности врача и наивысшего качества стоматологической помощи в Кузбассе.



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**